

高。此研究结果表明应用氟康唑治疗儿科病人严重的真菌感染是有效和安全的。

[Preste HE, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1994,13(4): 347(英文)张贵源摘 胡大清校]

胞,也有胆管的损害及增生改变。这可解释为使用氟氯西林引起长期和偶发的不可逆性肝脏疾病。

[Eckstein RP et al. Phathalogy. 1993,25(3): 223(英文) 今 朝摘译]

抗病毒药物的副作用和药物相互作用的临床意义

大多数抗病毒药物属于核苷同系物,具有潜在的致畸、胚胎毒性、致癌和抗增殖活性,故妊娠期应慎用。这类药物的副作用主要是骨髓抑制(如更昔洛韦引起的粒细胞减少,齐多夫定引起的贫血)或神经毒性(如 α -干扰素引起的癫痫发作,Zalcitabine引起的末梢神经炎),而对胃肠的影响也可见到。特异性反应是指由 didanosine(二脱氧肌苷)引起的急性胰腺炎。主要只有肌苷 pranobex 是无毒的。由于核苷全身副作用严重,故必须局部应用。抗病毒药物与其它药物的相互作用多半会产生毒性(如更昔洛韦和齐多夫定引起的中性白细胞减少,didanosine 和酒精引起的胰腺炎),而肾脏的排泄或肝脏的代谢也可能受到影响。由于抗病毒化疗可能会发生严重的副作用和药物相互作用,故仅用于潜在严重的病毒感染。局部给药不仅可避免全身副作用,而且还没有诱变的危险(如雾化利巴韦林)。

[Morris DJ, et al. Drug Saf. 1994,10(4): 281(英文)张贵源摘 胡大清校]

氟氯西林引起肝病:尸检及活检组织病理学研究结果

作者报道了 13 例氟氯西林(flucloxacillin)治疗后发生胆汁郁积的肝活检组织学表现。大多数病例有黄疸及皮肤瘙痒。几乎所有病例在随访平均 18 个月后肝功能试验恢复正常。1 例病人出现黄疸 7 个月后死亡,另 1 例临床证实为继发性胆汁性肝硬化。组织活检典型的表现为肝细胞和小管胆汁郁积,伴轻微或无肝炎。通常有轻度门静脉纤维化和门脉区斑状淋巴细胞浸润。4 例病人肝管数目减少,6 例胆管变小。胆管上皮细胞显示退行性变化,偶见炎性细胞浸润。胆管增生有很大差异。有些病例,大多为严重病例即使胆汁排空,难以觉察。结果表明,其损害不仅是肝细

对 202 例住院精神分裂症患者使用氯氮平的药物流行病学研究

目的:在一项大范围试验中评估氯氮平(Clozapine)对住院难治性精神分裂症患者的症状改善和副作用。方法:由一个大规模的州公共精神病学系统组成。方案要求精神科专科医生在药物治疗开始后进行 4 次症状和副作用的评定。治疗效果的评估标准包括症状改善的 Sandoz 研究评估标准以及出院后随访一年的情况。同时确定了控制评定一致性的几个措施,以保证结果评估的真实性。接受氯氮平治疗的患者共 227 例,而可获得症状资料的有 202 例。结果:总体上,在一年治疗结束时有 33% 病人($n=66$)症状获得改善,12% 的病人($n=24$)在 3 次评定时症状持续改善。至少在 152 例持续服药的患者中,于治疗 12w 后观察到简明精神病评定量表(BPRS)评分比用药前比较有显著的统计学意义。而既往治疗无效的病例($n=26$)的好转也说明了该药的治疗效果。然而,对整个 202 例(包括退出者)的分析显示,12w 后患者的病情并无显著的改善。在那些用药治疗一年的病人中,对既往治疗无改善的情况而言,症状改善的典型病例显示出后期改善的概率为 0.26,12w 有效者后又失去改善的概率是 0.23,最后在 100 例中获得改善的仅有 3 例。到一年终末时有 8% ($n=17$) 的病人出了院,3% ($n=7$) 转到别的门诊所继续接受氯氮平治疗。在起初开始接受氯氮平治疗的病人中,因副作用而中止治疗的占 11% ($n=25$)。白细胞计数(WBC)减少(但没有粒细胞减少)占 5% ($n=12$),癫痫发作占 1% ($n=3$),一病人癫痫发作伴有 WBC 减少,其它不良反应(如心血管系的改变,发热或可能的精神抑制剂恶性综合征)占 4% ($n=9$)。记录中,在开始治疗的病人中有 6% ($n=3$) 的病人拒绝治疗。结论:尽管在 6w 时仅有 19% 的病人显示出改善,但是这项自然组合的研究队列的 12w 有效率(29%)与大规模、双盲 6w 对照的氯氮平临床试验的结果是相似的。

[Zito JM, et al. Ann Pharmacother. 1993, 10(27):1262 刘奉贤摘 胡大清 方貽儒校]